

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANYA
TENTANG
PEKERJAAN PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 007.PJ.PkL/DAN.01.02/F48000000/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : 1610.1/U00000/2023-S0

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT** : Dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AKBAR** selaku *Vice President* Pelayanan *Human Capital* Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Kantor Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 1211.K/SDM.02.01/DIR/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang berkedudukan di Jl. Letjen Hertasning Blok B Makassar, sebagai Pengguna Barang/Jasa yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** : Dalam hal ini diwakili oleh **dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS** selaku Direktur Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya berdasarkan surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No.Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021 tentang Mutasi Pekerja PT Pertamina Bina Medika IHC, sebagai penyedia barang/jasa selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

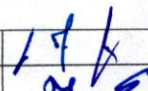
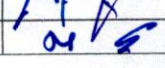
1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 018.P/DIR/2022 tanggal 7 Juli 2023 Tentang Kebijakan Strategis Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero).
2. Dokumen Pelelangan (RKS) Pekerjaan Kerjasama Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Oleh Rumah Sakit Sandi Karsa dengan Nomor : 0014.RKS/RENDAN/F48000000/2023, tanggal 26 Juni 2023
3. Surat No.007/DAN.01.02/LAKSDA/F48000000/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Undangan Pengadaan Barang/Jasa dan Surat No.014/DAN.01.02/LAKSDA/F48000000/2023 tanggal 23 Oktober 2023
4. Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) No.014.BAP/DAN.01.02/F48000000/2023 tanggal 18 Juli 2023
5. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No.014.BAEK/DAN.01.02/F48000000/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

6. Berita Acara Evaluasi Penawaran No.004.BAEP/DAN.01.02.07/F48000000/2023 tanggal 27 Oktober 2023
7. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.014.BAN/DAN.01.02/F48000000/2023 tanggal 27 Oktober 2023
8. Berita Acara Hasil Pengadaan No. 014.BAHP/DAN.01.02/LAKSDA/F48000000/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 perihal Hasil Pengadaan
9. Surat Penunjukkan Pemenang No.014.PPBJ/DAN.01.02/F48000000/2023 tanggal 31 Oktober 2023
10. Notulen Rapat CDA No.014.CDA/DAN.01.02/F48000000/2023 tanggal **1 November 2023**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian ini, yang dituangkan dalam Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

1. **APLN** adalah Anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau Keadaan Darurat (Emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP.
2. **Berita Acara Penjelasan** adalah berita acara yang disiapkan oleh Manager Pelaksana **Pengadaan** Barang/Jasa sehubungan dengan Penjelasan Dokumen Tender /RKS berikut Perubahan-perubahannya jika ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender /RKS.
3. **Berita Acara Serah Terima** Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat setelah fisik **pekerjaan** mencapai 100% (seratus persen).
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pengguna** Barang/Jasa dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran PT PLN (Persero).
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh **atau** sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar yang memuat setiap komponen pekerjaan yang **harus** dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa berikut harga satuannya (mata pembayaran) dan merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Barang/ Jasa
7. Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi/Direktur yang **bertanggungjawab** penuh atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN.
8. **Direksi Pekerjaan** adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian/Kontrak.
9. **Dokumen Aplikasi Kualifikasi** adalah dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan kepada kepada Manager Pelaksana Pengadaan dalam proses kualifikasi.
10. **Dokumen RKS atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)** adalah Dokumen yang menjadi pedoman bagi Penyedia Barang/Jasa untuk membuat penawaran dan sebagai pedoman bagi Manager pelaksana pengadaan dalam melakukan evaluasi penawaran.
11. **Dokumen Tender** adalah dokumen terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa meliputi antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi Kualifikasi, Dokumen Tender/RKS, Pengumuman, Berita Acara-Berita Acara, Dokumen Penawaran, Surat

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jaminan-jaminan, Contract Discussion Agreement (CDA), Perjanjian/Kontrak.
12. **Dokumen Penawaran** adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa yang disampaikan kepada Manager Pelaksana Pengadaan.
 13. **Gabungan lumpsum dan harga satuan** adalah jenis perpanjian/kontrak yang merupakan gabungan lummpsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang dijanjikan.
 14. **General Manager** adalah jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direktur Utama/Direktur yang mengelola Unit Induk/Pusat-pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama/Direktur terkait dengan jenjang jabatan Manajemen.
 15. **Harga Perkiraan Enjiniring (HPE)** adalah Perhitungan estimasi biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok pekerjaan yang dihitung secara cermat dan profesional sebagai dasar penyusunan HPS.
 16. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu barang/jasa yang dihitung berdasarkan estimasi biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor lain.
 17. **Hari** adalah hari kalender kecuali dinyatakan lain.
 18. **Jadwal Pengadaan Barang/Jasa** adalah rincian waktu proses Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup sejak tahap proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
 19. **Jasa Lainnya** adalah layanan jasa selain Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
 20. **Klarifikasi** adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Manager Pelaksana Pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa atas Substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
 21. **Komite Value for Money** adalah fungsi yang melakukan kajian/analisis Value for Money terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di PLN, pada tahap perencanaan pengadaan dan pada tahap laporan hasil pelelangan atau pada tahap usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa.
 22. **Kualifikasi** adalah tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa.
 23. **Masa Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak** adalah masa sejak ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak.
 24. **Negosiasi** adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan/atau waktu pelaksanaan antara Manager Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
 25. **Pagu Anggaran** adalah anggran maksimal yang terdapat dalam RKAP yang dihitung secara profesional berdasarkan perkiraan biaya pekerjaan ditambah dengan perkiraan penyesuaian karena kondisi ekonomi.
 26. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal atau horizontal, bertindak dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 27. **Manager Perencana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 28. **Manager Pelaksana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 29. **Pengguna Barang/ Jasa** adalah Direksi atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan kebutuhan dan batasan kewenangan yang berlaku, atau Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Manajemen Atas Khusus/ Manajemen Atas atau Manajer Unit Pelaksana yang diberi kuasa atau diberi pelimpahan wewenang, yang menggunakan

- dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari barang/ jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/ jasa.
30. **Pengawas Pekerjaan** adalah bertugas membantu Direksi Pekerjaan dalam pengawasan pekerjaan untuk menilai hasil pekerjaan Penyedia Barang/ Jasa.
 31. **Penilaian Kualifikasi** adalah kegiatan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/ Jasa.
 32. **Penyedia Barang/ Jasa** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau badan hukum publik lainnya, lembaga, konsorsium, Joint Operation, Firma, persekutuan perdata (Maatschap), badan usaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ jasa.
 33. **Perjanjian/ Kontrak** adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang / Jasa dengan Penyedia Barang/ Jasa.
 34. **PLN** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.
 35. **PLN UIP3B SULAWESI** adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran & Pusat Pengatur Beban Sulawesi, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM. 7, Tello Baru, Makassar
 36. **Proses Pengadaan Barang/ Jasa** adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi inisiasi Pengadaan Barang/ Jasa (identifikasi kebutuhan dan penganggaran), perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa, proses pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, penandatanganan Perjanjian/ Kontrak, pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak, dan serah terima hasil pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak.
 37. **Tahun Anggaran** adalah kurun waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 38. **Unit Induk** adalah organisasi satu tingkat di bawah Kantor Pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.
 39. **Unit Pelaksana** adalah organisasi satu tingkat di bawah Unit Induk yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.
 40. **Vice President Pelayanan Human Capital** adalah jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Executive Vice President Pelayanan Human Capital yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi data dan kesehatan yang prima di wilayah kerjanya, serta Memproses Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Provider Kesehatan.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup Pelayanan Kesehatan dalam kerjasama Rumah Sakit selaku Penyedia Layanan Kesehatan ini meliputi:

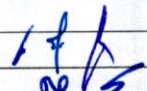
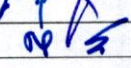
1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama (dokter umum di Poli Umum Rumah Sakit sebagai dokter pemberi rujukan). Kerjasama pembukaan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dapat dilakukan apabila pada lokasi/daerah setempat tidak ada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dapat digunakan/bekerjasama dengan PLN sebagai fasilitas layanan kesehatan primer
2. Pelayanan Medik Gigi Dasar dan Medik Gigi Spesialistik. Kerjasama pembukaan pelayanan medik gigi dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara PLN dan Rumah Sakit terkait tarif kewajaran pembiayaan pelayanan gigi
3. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap, pelayanan *one day care*, pelayanan penyediaan obat, pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta pelayanan

- penunjang (pemeriksaan dan rehabilitasi) secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanan kesehatan
4. Pelayanan kesehatan ini berlaku untuk seluruh Peserta Jaminan Kesehatan dari seluruh Unit Kerja PLN yang terdaftar secara valid yang diberikan bukti kepesertaan berupa Kartu PLN Sehat/e-card

PASAL 3

KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA** diperuntukkan bagi peserta yang terdiri dari Pegawai, Pensiunan dan Keluarga yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**. Peserta berhak mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan di mitra kerja penyedia layanan kesehatan yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** setelah mendapatkan Surat Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama baik dari dokter umum dan klinik yang dilanggan, atau dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I yang bermitra dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** hanya akan melayani dan menerima Peserta yang membawa kartu identitas, Surat Rujukan, serta Kartu PLN Sehat/e-card yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal fasilitas atau kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengatasi keluhan/diagnosa penyakit Peserta, **PIHAK KEDUA** wajib merujuk ke rumah sakit lain yang mampu menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dan diprioritaskan dirujuk ke rumah sakit yang telah bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**, atau Rumah Sakit Pemerintah Kelas A
4. Dalam hal terjadi rujukan sebagaimana angka 3, maka sebelumnya **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui APLN
5. Biaya mobilisasi/pemindahan yang timbul akibat dari rujukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi beban dan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA** yang merujuk.
6. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan tindakan dengan berdasarkan pertimbangan kesehatan/kondisi Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal diperlukan terapi yang memerlukan biaya tinggi (antara lain suntikan interferon, sitostatika, dll) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter yang merawat dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** melalui APLN
 - b. Pemeriksaan kesehatan yang tidak ditanggung/dijamin oleh **PIHAK PERTAMA** adalah pemeriksaan yang terlampir dalam lampiran perjanjian Kerjasama ini. Apabila berdasarkan pertimbangan medis, pemeriksaan tersebut harus diberikan, biaya menjadi beban peserta dan harus diselesaikan sebelum pasien pulang.
7. **PIHAK KEDUA** dalam memberikan tindakan operasi/tindakan medis lainnya harus mendapat persetujuan Peserta/keluarga Peserta **PIHAK PERTAMA** melalui APLN, kecuali Peserta dalam kondisi kritis/gawat/membahayakan keselamatan jiwa dapat diberikan tanpa persetujuan Peserta, dengan tetap diharuskan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga Peserta dan **PIHAK PERTAMA** melalui APLN
8. Dalam hal pemberian tindakan operasi/ tindakan medis lainnya Provider Kesehatan harus mendapat persetujuan Peserta/Keluarga Peserta dan PLN melalui APLN. Dikecualikan apabila Peserta dalam kondisi kritis/gawat maka dapat diberikan tanpa persetujuan Peserta, dengan tetap diharuskan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga Peserta dan **PIHAK PERTAMA** melalui APLN
9. Dalam hal Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau Rawat Inap yang memerlukan tindakan/pemeriksaan dengan biaya diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau biaya resep 1 jenis obat diatas Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka **PIHAK KEDUA** wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** melalui APLN, kecuali untuk tindakan darurat yang membutuhkan pertolongan sangat segera

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- dapat dilakukan sementara melalui persetujuan secara lisan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang selanjutnya tetap dilakukan permintaan persetujuan tindakan secara tertulis.
10. Dalam hal perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka pemilihan jenis pemeriksaan penunjang harus ditulis dengan jumlah pilihan yang dituangkan dalam angka dan huruf pada formulir pemeriksaan penunjang.
 11. Resep dokter untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan pasca Rawat Inap, dapat diambil di apotek **PIHAK KEDUA** atau apotek yang bermitra dengan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
 - a. Untuk jenis penyakit akut, penulisan resep maksimal 4 (empat) jenis obat untuk maksimal 5 (lima) hari;
 - b. Untuk jenis penyakit kronis, penulisan resep maksimal 6 (enam) jenis obat untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari;
 - c. Penulisan Resep iter diperbolehkan maksimal untuk 3 (tiga) kali pengambilan.
 12. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan obat, sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** dengan prioritas pemberian sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. Generik;
 - b. PMDN;
 - c. PMA;
 - d. Original (Paten).
 13. Obat-obatan yang diberikan kepada Peserta sesuai Formularium Obat (FO) dan Daftar Obat Perseroan (DOP) dari **PIHAK PERTAMA**, kecuali jika tidak ada dalam Formularium Obat (FO) dan Daftar Obat Perseroan (DOP) dari **PIHAK PERTAMA**, maka dapat diberikan obat-obatan sejenis berdasarkan Daftar Obat Kesepakatan (DOK) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau berdasarkan pertimbangan medis dengan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** melalui APLN.
 14. Vitamin yang dijaminakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah untuk kriteria sebagai berikut:
 - a. Peserta Rawat Inap yang membutuhkan Vitamin sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
 - b. Peserta pasca Rawat Inap/dalam masa penyembuhan atas rekomendasi dokter yang merawat;
 - c. Peserta yang menderita Hepatitis Kronis, TBC, Karsinoma (Kanker);
 - d. Peserta yang menderita Defisiensi Vitamin;
 - e. Peserta dengan gangguan syaraf yang telah dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang neurologis;
 - f. Peserta adalah Ibu Hamil dan Anak sampai dengan usia 5 tahun.
 15. Kepesertaan **PIHAK PERTAMA** dan Pegawainya pada program JKN BPJS Kesehatan
 - a. **PIHAK PERTAMA** dan Pegawainya beserta keluarga yang ditanggung merupakan peserta aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan, oleh karenanya pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** yang telah memiliki mekanisme pelayanan JKN agar dalam penagihan biaya kesehatan dari **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan sistematika program koordinasi manfaat/*cost- splitting/split-billing*;
 - b. Penagihan dari **PIHAK KEDUA** yang telah memiliki mekanisme pelayanan JKN ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan perhitungan biaya pelayanan kesehatan berdasarkan tarif pelayanan dan pengobatan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**, setelah dikurangi dengan tarif INA-CBGs yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan, untuk kemudian selisihnya ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 16. Dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, **PIHAK KEDUA** tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan perawatan pada Peserta.

17. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** dan wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada Peserta.

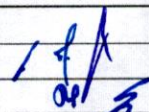
PASAL 4
KETENTUAN PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama yang dilakukan di Poli Umum **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan kerjasama pembukaan layanan apabila pada lokasi/daerah setempat tidak terdapat fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dapat digunakan/bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat layanan kesehatan primer. Kerjasama untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama ini diatur sebagai berikut:

1. Pelayanan Poli Umum **PIHAK KEDUA** dapat menerima peserta **PIHAK PERTAMA** dan dokter poli umum dijadikan dokter pemberi rujukan Rumah Sakit/dokter spesialis dengan jadwal.
2. Untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama pada Poli Umum **PIHAK KEDUA**, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/e-card dan kartu identitas kepada Poli Umum **PIHAK KEDUA** saat melakukan pendaftaran.
3. **PIHAK KEDUA** harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu PLN Sehat/e-card pada *Front End System* APLN untuk mencetak *Letter of Authorization* (LoA). Setelah mendapatkan LoA, maka Peserta berhak untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dari Poli Umum **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila pemeriksaan kesehatan pada Rawat Jalan Tingkat Pertama selesai, **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan *Letter of Confirmation* (LoC) dan menuliskan diagnosa, rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Rumah Sakit dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan (LoC) dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter Poli Umum sebagai fasilitas Rawat Jalan Tingkat Pertama peserta disarankan untuk mendapatkan layanan dokter spesialis, maka dokter poli umum akan memberikan rujukan ke pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan pada dokter Spesialis **PIHAK KEDUA**.
6. Surat Rujukan sebagaimana dimaksud berlaku untuk 1 (satu) orang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan untuk perawatan hemodialisa berlaku untuk 1 (satu) bulan, dan hanya dapat dipergunakan untuk pemeriksaan sesuai yang tercantum pada Surat Rujukan tersebut.
7. Dalam pemberian fasilitas pemeliharaan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, **PIHAK KEDUA** diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

PASAL 5
KETENTUAN PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN, PELAYANAN RAWAT INAP, PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT, PELAYANAN KONDISI DARURAT, DAN PELAYANAN PENUNJANG

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
 - a. Bagi peserta yang dirujuk untuk mendapatkan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada dokter spesialis **PIHAK KEDUA**, maka peserta diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/e-card, kartu identitas, dan surat

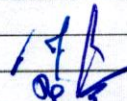
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

rujukan dari fasilitas kesehatan yang memberikan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama kepada Poli Spesialis **PIHAK KEDUA** saat melakukan pendaftaran.

- b. Poli Spesialis **PIHAK KEDUA** harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu PLN Sehat/e-card pada Front End System APLN untuk mencetak Letter of Authorization (LoA). Setelah mendapatkan LoA, maka Peserta berhak untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada Poli Spesialis **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan *Letter of Confirmation* (LoC) dan menuliskan diagnosa, rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Rumah Sakit dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan (LoC) dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter Poli Spesialis sebagai fasilitas Rawat Jalan Tingkat Lanjutan peserta disarankan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosa pada dokter spesialis lainnya, maka dokter poli spesialis dapat memberikan rujukan kepada dokter spesialis lainnya dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari.
- e. Bagi Peserta yang telah melakukan proses Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud huruf b dan/atau huruf d namun diberikan surat kontrol dari dokter **PIHAK KEDUA**, maka untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan selanjutnya dengan diagnosa yang sama, khusus untuk Surat Rujukan sebagaimana dimaksud huruf d dapat digantikan dengan surat kontrol yang memiliki masa berlaku selama 1 (satu) bulan.
- f. Dalam pemberian fasilitas pemeliharaan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, **PIHAK KEDUA** diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

2. Pelayanan Rawat Inap

- a. Untuk mendapatkan Pelayanan Rawat Inap, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/e-card dan kartu identitas kepada **PIHAK KEDUA** yang disertai rekomendasi/rujukan dari dokter Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I.
- b. Peserta dalam kondisi tertentu (antara lain : cuti bersama, libur hari raya, libur nasional) dapat langsung ke **PIHAK KEDUA** untuk menjalani Rawat Inap atau tindakan lainnya yang diperlukan, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** harus menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui APLN untuk mendapatkan Surat Jaminan.
- c. Setelah menerima Surat Jaminan sementara dari **PIHAK PERTAMA** melalui APLN, **PIHAK KEDUA** wajib melayani Peserta dengan tindakan dan obat yang disepakati dengan proses verifikasi dari penjaminan APLN.
- d. Jangka waktu pelaporan maksimum 2x24 jam sejak masuk Rumah Sakit, dan apabila jatuh pada hari libur maka dihitung sejak hari kerja pertama dengan membawa Surat Keterangan Rawat Inap dari **PIHAK KEDUA** disertai dengan keterangan tertulis dari Dokter yang merawat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang diderita dan apabila tidak melaporkan maka biaya Pemeliharaan Kesehatan diberikan secara Restitusi sesuai Tarif Perseroan.
- e. Pengaturan hak kelas Rawat Inap Peserta sesuai data yang tercantum dalam LoA yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan atau melalui Informasi dari **PIHAK PERTAMA** melalui APLN.
- f. Apabila Peserta yang menjalani Rawat Inap menempati kamar perawatan yang tidak sesuai dengan haknya, maka selisih tarif tindakan medis, tarif obat, tarif kamar dan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

tarif non kamar/jasa layanan tersebut menjadi tanggungan Peserta yang bersangkutan dan wajib diselesaikan sebelum Peserta pulang.

- g. Apabila hak kelas Rawat Inap Peserta penuh berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit, maka **PIHAK KEDUA** wajib memfasilitasi naik kelas satu tingkat diatas hak kelasnya selama 2x24 jam dan seluruh selisih biaya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
 - h. Apabila pada hari ke-3 dan seterusnya kelas Rawat Inap yang menjadi hak Peserta masih belum tersedia, maka Peserta diberikan opsi untuk tetap menempati kelas Rawat Inap yang lebih tinggi tersebut dengan selisih biaya ditanggung oleh Peserta (menjadi excess charge) atau Peserta dimaksud turun kelas Rawat Inap.
 - i. Rawat Inap sampai dengan 1 (satu) bulan berturut-turut harus dikunjungi oleh Dokter Koordinator **PIHAK PERTAMA**/Dokter Klinik **PIHAK PERTAMA** untuk dilaksanakan evaluasi.
 - j. Rawat Inap dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan per Peserta secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun, kecuali atas rekomendasi MAB.
 - k. Dalam hal situasi Peserta dalam keadaan kritis, tindakan apapun yang diputuskan harus memperhatikan *outcome* jangka pendek dan jangka panjang. Tindakan medis apapun tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Peserta apabila tidak disertai rekomendasi bukti ilmiah.
 - l. Dalam hal Peserta memerlukan perawatan di ruang khusus (ICU/Intermediate/Isolasi) maka **PIHAK KEDUA** harus dapat menyampaikan keterangan tertulis perihal indikasi terkait kebutuhan menempati ruangan khusus tersebut serta berkoordinasi dengan APLN mengenai tarif tindakan dan jasa dokter sesuai dengan hak kelas Peserta.
 - m. Obat yang direkomendasikan oleh Dokter Rumah Sakit, namun tidak ada didalam DOP maupun DOK harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - n. Berdasarkan keterangan atau informasi dari dokter Rumah Sakit yang merawat bahwa Peserta diijinkan pulang atau selesai menjalani Rawat Inap, maka **PIHAK KEDUA** agar segera menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui APLN dan Peserta tanpa harus menunggu sampai dengan batas waktu tertentu dengan maksud menambah jumlah hari perawatan.
 - o. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan bahwa Peserta menandatangani seluruh tagihan pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya termasuk honor dokter, honor anestesi dan lain-lain yang berkaitan dengan tagihan perawatan yang bersangkutan.
 - p. Dalam pemberian fasilitas pemeliharaan kesehatan Rawat Inap, Rumah Sakit diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.
3. Pelayanan Penyediaan Obat
- a. Untuk mendapatkan pelayanan penyediaan obat, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/*e-card*, Kartu Identitas, LoC, dan Resep dari Dokter **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pemberian obat untuk Peserta memperhatikan ketentuan pada bagian Ketentuan Pelayanan Kesehatan.
 - c. Pada saat penyerahan obat bagi Peserta, **PIHAK KEDUA** harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - i. Dilakukan pemotongan kemasan obat (tidak diberikan dalam keadaan strip utuh)
 - ii. Pemotongan kemasan obat dilakukan didepan Peserta sesaat sebelum penyerahan obat dengan terlebih dahulu menginformasikan waktu kedaluwarsa dari obat tersebut.

- iii. Penyerahan obat tidak menyertakan dus/box obat, kecuali lembaran informasi obat tetap diberikan.
 - iv. Sediaan obat sirup kering telah dilarutkan di bagian farmasi.
 - v. Apabila terdapat keberatan/komplain dari Peserta, maka pemotongan kemasan obat tetap dilaksanakan sesuai poin diatas, dan agar di informasikan terkait Peserta yang keberatan/komplain tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**
 - d. Dalam hal di lokasi/kedudukan Peserta tidak tersedia Apotek Mitra Kerja, maka resep obat dapat dibeli langsung ke Apotek lainnya dengan mekanisme Restitusi.
 - e. Resep untuk obat termasuk peresepan diulang (iter) baik yang ada di dalam maupun di luar FO dan DOP disarankan diambil/dibeli ke Apotek Mitra Kerja terlebih dahulu dan apabila obat tersebut tidak tersedia, maka dapat membeli di Apotek lainnya dengan mekanisme Restitusi.
4. Pelayanan Kondisi Gawat Darurat
- a. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kondisi gawat darurat, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/*e-card*, dan kartu identitas, tanpa harus melalui mekanisme surat rujukan dari dokter/klinik kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Apabila Peserta tidak membawa atau menunjukan Kartu PLN Sehat/*e-card* sebagaimana huruf a dan kondisi Peserta membutuhkan pertolongan pertama, maka Peserta diprioritaskan masuk ke IGD terlebih dahulu, Surat Jaminan akan menyusul disampaikan setelah keluarga Peserta melapor kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan informasi kepesertaan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pelayanan gawat darurat dapat dilayani oleh **PIHAK KEDUA** apabila Peserta **PIHAK PERTAMA** memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Sakit yang diderita Peserta memenuhi kriteria kondisi gawat darurat
 - ii. Peserta berobat pada hari libur/hari libur nasional.
 - iii. Peserta berobat pada hari Senin hingga hari Jum'at mulai pukul 20.00 WIB dan hari Sabtu mulai Pukul 16.00 WIB.
 - d. Dalam kondisi darurat gawat, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tindakan operasi/tindakan medis lainnya tanpa persetujuan Peserta/keluarga Peserta, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** melalui APLN.
5. Pelayanan Penunjang
- a. Pelayanan penunjang meliputi Pemeriksaan Penunjang dan kegiatan rehabilitasi.
 - b. Pemeriksaan Penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi atau *rontgen* dan pemeriksaan patologi anatomi sedangkan kegiatan rehabilitasi antara lain kegiatan fisioterapi dan terapi wicara/okupasi.
 - c. Untuk mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan Penunjang, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/*e-card*, dan Kartu Identitas kepada **PIHAK KEDUA** disertai:
 - i. Untuk pemeriksaan awal dilampiri surat rujukan dari dokter atau klinik yang bermitra dengan **PIHAK PERTAMA**
 - ii. Untuk pemeriksaan lanjutan disertai surat rujukan dari dokter spesialis **PIHAK KEDUA**
 - d. Untuk pemeriksaan rehabilitasi meliputi kegiatan fisioterapi, terapi wicara dilakukan maksimal 3 Cure (18 kali) dengan membawa Kartu PLN Sehat/*e-card*, dan Kartu Identitas dan jadwal fisioterapi.
 - e. Dalam menerapkan Pelayanan Pemeriksaan Penunjang dan rehabilitasi Rumah Sakit juga tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan perawatan pada Peserta.

PASAL 6

KETENTUAN PELAYANAN MEDIK GIGI DASAR DAN PELAYANAN MEDIK GIGI SIALISTIK

Pelayanan kesehatan gigi merupakan hal yang dijaminakan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**. Cakupan dan batasan penjaminan pelayanan kesehatan gigi terdapat dalam Lampiran. Kerjasama pembukaan layanan medik gigi dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara PLN dan Rumah Sakit terkait tarif kewajaran pembiayaan pelayanan gigi. Kerjasama untuk Pelayanan Medik Gigi Dasar dan Medik Gigi Spesialistik diatur sebagai berikut:

1. Pelayanan Medik Gigi Dasar
 - a. Pelayanan Medik Gigi Dasar adalah kegiatan pelayanan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier, yang dilaksanakan tenaga profesional kesehatan gigi dan mulut, baik berupa tindakan kompleks maupun sederhana, sesuai standar yang berlaku.
 - b. Pelayanan Medik Gigi Dasar di Poli Gigi **PIHAK KEDUA** dapat menerima peserta PLN dan dokter gigi umum dijadikan dokter pemberi rujukan Rumah Sakit/dokter spesialis dengan jadwal sesuai yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Untuk mendapatkan pelayanan medik gigi dasar pada Poli Gigi **PIHAK KEDUA**, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/e-card, dan kartu identitas kepada Poli Gigi **PIHAK KEDUA** saat melakukan pendaftaran.
 - d. **PIHAK KEDUA** harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu PLN Sehat/e-card pada **Front End System APLN** untuk mencetak *Letter of Authorization* (LoA). Setelah mendapatkan LoA, maka Peserta berhak untuk mendapatkan pelayanan medik gigi dasar dari Poli Gigi **PIHAK KEDUA**.
 - e. Apabila pemeriksaan kesehatan pada medik gigi dasar selesai, **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan *Letter of Confirmation* (LoC) dan menuliskan diagnosa, rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Rumah Sakit dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan (LoC) dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter gigi umum sebagai fasilitas Rawat Jalan Tingkat Pertama peserta disarankan untuk mendapatkan layanan dokter gigi spesialis, maka dokter gigi umum akan memberikan rujukan ke pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan pada dokter gigi spesialis.
 - g. Surat Rujukan sebagaimana dimaksud berlaku untuk 1 (satu) orang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan hanya dapat dipergunakan untuk pemeriksaan sesuai yang tercantum pada Surat Rujukan tersebut.
 - h. Dalam pemberian fasilitas pemeliharaan kesehatan medik gigi dasar, **PIHAK KEDUA** diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.
2. Pelayanan Medik Gigi Spesialistik
 - a. Pelayanan Medik Gigi Spesialistik adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang diberikan oleh tenaga kedokteran gigi sesuai dengan bidang gigi spesialistik yang diakui oleh profesi kedokteran gigi dan sesuai standar yang berlaku.
 - b. Bagi peserta yang dirujuk untuk mendapatkan Pelayanan medik gigi spesialistik pada dokter gigi spesialis, maka peserta diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan Kartu PLN Sehat/e-card, kartu identitas, dan surat rujukan dari dokter gigi umum yang memberikan pelayanan medik gigi dasar kepada Poli Gigi Spesialis **PIHAK KEDUA** saat melakukan pendaftaran.

- c. Poli Gigi Spesialis **PIHAK KEDUA** harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu PLN Sehat/*e-card* pada Front End System APLN untuk mencetak *Letter of Authorization* (LoA). Setelah mendapatkan LoA, maka Peserta berhak untuk mendapatkan pelayanan medik gigi spesialistik pada Poli Spesialis **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib mendapatkan Letter of Confirmation (LoC) dan menuliskan diagnosa, rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Rumah Sakit dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan (LoC) dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter Poli Gigi Spesialis sebagai fasilitas Rawat Jalan Tingkat Lanjutan peserta disarankan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan pada dokter spesialis lainnya, maka dokter gigi spesialis dapat memberikan rujukan kepada dokter gigi spesialis lainnya dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari.
- f. Bagi Peserta yang telah melakukan proses Pelayanan Gigi Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud huruf b dan/atau huruf d namun diberikan surat kontrol dari dokter **PIHAK KEDUA**, maka untuk Pelayanan Gigi Medik Spesialistik selanjutnya dengan diagnosa yang sama, khusus untuk Surat Rujukan sebagaimana dimaksud huruf d dapat digantikan dengan surat kontrol yang memiliki masa berlaku selama 1 (satu) bulan.
- g. Dalam pemberian fasilitas pemeliharaan kesehatan Pelayanan Gigi Medik Spesialistik, **PIHAK KEDUA** diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

PASAL 7

SKEMA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMANFAATAN KEPESERTAAN PADA BPJS KESEHATAN

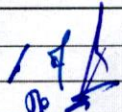
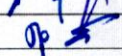
1. Pelayanan Kesehatan di Klinik yang dapat memanfaatkan Jaminan dari BPJS Kesehatan agar dapat dioptimalkan melalui Kepatuhan pada Skema layanan JKN yang akan dipertimbangkan dalam perhitungan tagihan akhir kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sistematika program koordinasi menfaat/ *cost-splitting/split-billing/coordination of benefit (COB)*.
2. Informasi terkait data Kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional akan diinformasikan kepada Klinik oleh **PIHAK PERTAMA** melalui/tanpa melalui TPA.

PASAL 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan resume medis Peserta yang ditujukan langsung pada **PIHAK PERTAMA** dan untuk hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pernyataan dan Jaminan ini, **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mendapat izin dan kuasa dari Peserta untuk meminta dan/atau menerima resume medis Peserta, baik secara lisan maupun tertulis dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin untuk melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala klaim dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun sehubungan dengan penunjukan dan/atau pemberian resume medis Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga sepanjang untuk kepentingan pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian ini.

12/22

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan/atau menyebarluaskan segala data, laporan dan/atau dokumen lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada peraturan atau kebijakan internal **PARA PIHAK** ("Informasi Rahasia") kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus/wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi Rahasia tetap wajib untuk dijaga oleh pihak sekalipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

- i. Mendapatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** setiap waktu jika secara medis diperlukan
- ii. Mengawasi tata laksana pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan pada **PIHAK KEDUA** dan apabila dianggap perlu dapat memberi teguran secara lisan atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang apabila pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
- iii. Menginformasikan dan menanyakan lampiran-lampiran secara terperinci atas tagihan Pelayanan Kesehatan yang dianggap perlu atau dinilai meragukan terhadap fasilitas yang diberikan pada Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**
- iv. Berhak menunda pembayaran untuk sementara waktu atas tagihan sebagaimana dimaksud angka 3), dan memproses lanjut apabila informasi secara tertulis atas kebenaran terhadap tagihan dimaksud tersebut telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- i. **PIHAK PERTAMA** melalui/tanpa melalui TPA berkewajiban menyerahkan Surat Jaminan kepada Rumah Sakit bagi Peserta yang memerlukan Pelayanan Kesehatan pada **PIHAK KEDUA**, seandainya Peserta tersebut belum memiliki kartu PLN Sehat/e-card
- ii. Melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**, yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**

- i. **PIHAK KEDUA** berhak menolak Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**, apabila data yang ada pada Surat Jaminan/Surat Rujukan/Kartu PLN Sehat/e-card/Kartu Identitas dengan data Calon Peserta Jaminan Kesehatan tidak ada kecocokan atau kesesuaian (baik jenis kelamin, usia dan lain-lain yang terkait dengan eligibilitas data Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**).
- ii. **PIHAK KEDUA** berhak menanyakan Surat Jaminan/Surat Rujukan/Kartu PLN Sehat/e-card /Kartu Identitas kepada Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA** sebelum yang bersangkutan akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

- iii. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas semua Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA** dengan menyampaikan berkas tagihan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam syarat- syarat pembayaran.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dengan menggunakan seluruh kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
- ii. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan pedoman pengobatan/indikasi medis secara umum, sesuai dengan indikasi medis dan *evidence base*, sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar profesi yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.
- iii. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengendalikan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan tentang Pelayanan Kesehatan dirumah sakit.
- iv. **PIHAK KEDUA** wajib menolak permintaan Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA** yang menghendaki pemeriksaan lain (termasuk obat lain-lain) yang secara medis tidak diperlukan atau mengubah tanggal perawatan dan mengubah diagnosa, apabila permintaan tersebut dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka seluruh biaya yang timbul bukan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- v. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan diagnosa perawatan Peserta Jaminan Kesehatan **PIHAK PERTAMA** setelah yang bersangkutan pulang dari Rumah Sakit, bersamaan dengan tagihan biaya Kesehatan.
- vi. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis apabila ada Peserta Jaminan Kesehatan yang sakit kronis selama lebih dari 1 (satu) bulan dan memerlukan perawatan serta obat dalam waktu yang cukup lama.

PASAL 10

Service Level Agreement (SLA)

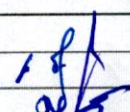
1. Tidak ada penyimpanan pemberian resep obat dalam hal pelayanan Kesehatan.
2. Tidak ada penyimpanan pemberian Tindakan dalam hal pelayanan Kesehatan
3. **PIHAK KEDUA** melalui Dokter Umum memberikan laporan kategori status Kesehatan pegawai, pensiunan dan keluarga yang ditanggung kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Manajemen Pelayanan HC Regional Setempat **c.p Assistant Manager Pelayanan HC**
4. Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya
5. Melakukan kunjungan berkala/rutin ke pasien dengan kategori perlu perhatian.
6. Tingkat optimalisasi pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan yang dikombinasikan dengan jaminan kesehatan PLN sejauh memungkinkan dan memenuhi ketentuan.

PASAL 11

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** selaku Penyedia Layanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai, Pensiunan, dan Keluarganya di

14/22

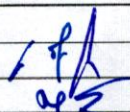
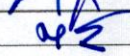
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- lingkungan **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak, yang dievaluasi secara periodik dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kebutuhan dan sepanjang masih ada kesesuaian harga dan kualitas.
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama dengan Penyedia Layanan Kesehatan dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diteruskan apabila hasil evaluasi periodik menyatakan bahwa:
 - a. Penyedia Layanan Kesehatan masih memenuhi kriteria pada penilaian kredensialing/rekredensialing fasilitas penyedia layanan kesehatan dan *Integrity Due Diligence*;
 - b. Penyedia Layanan Kesehatan menunjukkan kinerja layanan pemeliharaan kesehatan yang baik;
 3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada angka 2 maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri/memutus perjanjian secara sepihak;
 4. Dalam hal terjadi pemutusan kerjasama oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu kerjasama berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan pemutusan kerjasama secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perjanjian kerjasama berakhir.
 5. Apabila salah satu PIHAK memutuskan Kerjasama sebelum waktu Kerjasama berakhir, maka kedua belah pihak sepakat untuk memberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
 6. Ketentuan waktu Pelaksanaan dan dimulainya Perjanjian lebih lanjut akan dibahas lebih rinci pada saat *Contract Discussion Agreement (CDA)*.

PASAL 12 NILAI PEKERJAAN / TARIF

Perhitungan biaya pelayanan kesehatan Peserta **PIHAK PERTAMA** yang dibebankan **PIHAK KEDUA** selaku Penyedia Layanan Kesehatan didasarkan atas tarif dan harga yang akan disepakati bersama dan dituangkan dalam satu kesepakatan tarif dan harga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat dan akan dituangkan pada lampiran Perjanjian yang meliputi kesepakatan antara lain tentang:

1. Tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada Lampiran perjanjian ini.
2. Harga obat mengikuti rumusan sebagai berikut :
HJA = (HNA + 11% PPN) x 1,20
HJA = Harga Jual Apotik
HNA = Harga Netto Apotik
3. Tarif pelayanan kesehatan termasuk Alat Kesehatan yang berlaku dalam kesepakatan adalah Tarif Pelayanan yang ditetapkan dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Dalam hal apabila berkas tagihan yang disampaikan di luar tarif kesepakatan, maka berkas tagihan yang dimaksud akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pembetulan sebagaimana tarif yang telah disepakati bersama.
5. Dalam hal apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelayanan kesehatan Peserta menggunakan Dokter Tamu, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
6. Dalam hal terjadi perubahan tarif yang telah ditawarkan maka Penyedia Layanan Kesehatan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk persetujuan lebih lanjut paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pemberlakuan tarif baru.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

7. Perubahan tarif hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama dengan berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku.
8. Untuk Badan Usaha yang memiliki jaringan Rumah Sakit lebih dari 1 (satu) maka untuk tarif dan kesepakatan tarif untuk masing-masing Rumah Sakit, bila diperlukan akan dibuat dan disepakati secara individual yang akan dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 13 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Semua pekerjaan yang merupakan bagian dari kontrak harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
2. Pengiriman Surat Permohonan Pembayaran beserta berkas tagihan dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan ke **PIHAK PERTAMA** harus disusun dengan rapi dan dikelompokkan berdasarkan Unit PLN asal Peserta dengan pendistribusian berkas sebagai berikut:
 - a. Berkas tagihan (*softcopy*) dikirim ke APLN secara online melalui *Front End System*.
 - b. Sedangkan tembusan surat permohonan pembayaran, rekapitulasi tagihan dan lampiran berkas (*hardcopy*) dikirim ke Pelayanan HC setempat **c.q. Assistant Manager Pelayanan HC**.
3. Dalam pelaksanaan penagihan untuk rawat jalan/rawat inap, **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi dan menyerahkan berkas tagihan yang dikirim ke TPA yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini adalah APLN, dengan melampirkan:

No.	Kelengkapan Berkas
1.	Surat Permohonan Pembayaran
2.	Peserta dengan Kartu PLN Sehat/e-card : Form Klaim
3.	• Peserta dengan Kartu PLN Sehat/e-card: LoC yang telah ditandatangani oleh Peserta • Peserta dengan Surat Jaminan : <i>copy</i> Surat Jaminan
4.	Kwitansi 2 (dua) rangkap, lembar pertama asli bermaterai secukupnya
5.	Persetujuan tindakan oleh Peserta atau keluarga Peserta
6.	Surat Rujukan asli dari dokter umum/dokter spesialis yang bermitra dengan PIHAK PERTAMA
7.	Formulir Pemeriksaan Penunjang /diagnostik dan hasilnya
8.	• Peserta dengan Kartu PLN Sehat/e-card: Rekapitulasi tagihan disertai nomor Kartu PLN Sehat, Nama Peserta, tanggal berobat & biaya pengobatan. • Peserta dengan Surat Jaminan : Rekapitulasi tagihan disertai NIP, Nama Peserta, tanggal berobat & biaya pengobatan
9.	Faktur Pajak

4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas jasa Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Obat dari **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah berkas tagihan diterima dari APLN yang dinyatakan lengkap dan benar. Pembayaran dilakukan melalui rekening bank yang disepakati dan dituliskan dalam Perjanjian dengan Format sebagai berikut:
 Nama Bank : BANK BNI
 No. Rekening : 6336336628

Atas Nama : Pertamina Bina Medika IHC
NPWP : 01.061.167.1-051.000

5. Dokumen tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertuang pada angka 3, dikirimkan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak **PIHAK PERTAMA** mendapatkan LoC atau penandatanganan surat keluar oleh Peserta/keluarga Peserta dari **PIHAK KEDUA**.
6. Jika **PIHAK KEDUA** belum mengirimkan tagihan sebagaimana dimaksud angka 5, maka tagihan dianggap kedaluwarsa dan tidak akan diproses pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**.
7. Proses verifikasi dokumen tagihan dilakukan oleh APLN, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja sejak diterimanya dokumen tagihan lengkap dan benar, dan selanjutnya APLN akan menyerahkan dokumen tagihan yang telah diverifikasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan proses pembayaran.
8. **PIHAK PERTAMA** melalui APLN berhak mengembalikan berkas tagihan **PIHAK KEDUA** apabila tarif dan berkas tagihan tidak sesuai dengan ketentuan untuk dikoreksi atau dilengkapi.
9. Bagi Badan Usaha yang memiliki jaringan Rumah Sakit lebih dari 1 (satu) yang berada dalam satu naungan, atau gabungan dari beberapa Badan Usaha Rumah Sakit yang dikelola oleh 1 (satu) Badan Usaha Induk, apabila memungkinkan maka proses pembayaran tagihan diupayakan untuk dilakukan pada 1 (satu) titik pembayaran di Badan Usaha Induk.

PASAL 14

DIREKSI PEKERJAAN DAN PENGAWAS PEKERJAAN

Direksi Pekerjaan Kerjasama Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan untuk Pegawai, Pensiunan dan Keluarga yang ditanggung oleh PT PLN (Persero) yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit (Group/Non Group) adalah **Manager Pelayanan Human Capital Sulawesi**.

Direksi Pekerjaan bertugas mengelola dan mengawasi administrasi perjanjian kerjasama dan mengendalikan pekerjaan.

Pengawas Pekerjaan untuk pekerjaan ini adalah **Assistant Manager Pelayanan Human Capital Makassar pada Bidang Pelayanan Human Capital Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara**.

Pengawas Pekerjaan mempunyai tugas, antara lain:

1. Memantau, Melayani, Mengevaluasi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk Peserta.
2. Memberikan bimbingan, pembinaan dan teguran tertulis kepada Rumah Sakit.
3. Melakukan verifikasi semua dokumen-dokumen penagihan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan selalu bertindak sebagai wakil sah **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Apabila ada perubahan pada perjanjian yang telah disepakati antara **PARA PIHAK**, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini akan dibuat dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian;

3. Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
4. Usul perubahan dan lain-lain seperti tersebut angka 1 dan angka 2 harus diajukan oleh Pihak yang satu kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

PASAL 16 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Penyelesaian Perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi atau konsiliasi.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara **PARA PIHAK** atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.
3. Jika perselisihan di atas tidak dapat diselesaikan secara damai/mufakat maka masing-masing **PIHAK** berhak untuk mengajukan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Makassar lembaga pemutus sengketa : **Pengadilan Republik Indonesia**

PASAL 17 **FORCE MAJEURE/KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
 - a. Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
2. Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
4. Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari **PARA PIHAK**.
6. Hal-hal / peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah / Pemerintah Daerah setempat.
7. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar.
8. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak.

9. Telah memberitahukan kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
10. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
11. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini segera dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak.
12. Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan Kahar dan tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 18 KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA

Untuk korespondensi terkait perjanjian Kerjasama dapat menghubungi **PIHAK PERTAMA** melalui:

Nama : PT PLN (Persero) Pelayanan Human Capital Makassar
Alamat : PT PLN (Persero) UID Sulserabar
Jl. Hertasning Blok B, Panakukang, Makassar

Dinna Fajarianti (Assistant Manager) 081354709508
Amalia (085255928063)
Firdayanti (081527294960)

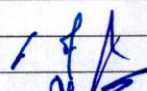
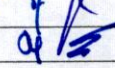
Untuk korespondensi terkait administrasi pelayanan kesehatan dan administrasi penagihan dapat menghubungi **PIHAK PERTAMA** melalui:

Nama : PLN Insurance
Alamat : PT PLN (Persero) UID Sulserabar
Jl. Hertasning Blok B, Panakukang, Makassar
081119088123 / 085964244551
WA 082344442865 / 081524230351
yanhc.sulmapana@pln.co.id

PLN Insurance Kantor Pusat
Jl. Raya Pasar Minggu No.5 Pancoran, Jakarta Selatan.
cs@plninsurance.co.id
penjamin@plninsurance.co.id
(021) 50809920

PIHAK KEDUA

Nama : Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya
Alamat : Jl. Pajjaiang Sudiang Raya Kec. Biringkanaya
rsoj.prb@gmail.com
(0411) 482 1000

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

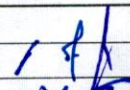
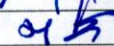
Telp

: Andi Dewi Sari (085255125126), Rati Rufiyanti (08114664702),
Muhammad Iskandar Zulkarnain (081255588138)

PASAL 19
INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNMENT

1. Sehubungan dengan hal-hal, dokumen-dokumen, kegiatan-kegiatan, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam atau terkait dengan Pekerjaan ini, Pengguna **PARA PIHAK** tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Kontrak ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, termasuk peraturan yang mengatur mengenai Tata Kelola Anti Penyuapan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
2. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
3. **PARA PIHAK** mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang serta kebijakan **PIHAK PERTAMA** mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan di seperti:
 - a. Menerapkan 4 No's:
 1. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan.
 2. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 3. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya
 4. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan.
 - b. Mengikuti prosedur uji kelayakan berbasis integritas (*integrity due diligence*) yang diterapkan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mengikuti program sosialisasi sistem manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** dan dapat diwakili oleh pegawai **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas.
 - e. Melaporkan insiden fraud melalui *Whistle Blowing System* **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan **PIHAK KEDUA** ketika terdapat indikasi ketidakwajaran berupa *overcharge* atau *overprice* dari tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian tagihan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan ketentuan dalam Kontrak.

20/22

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

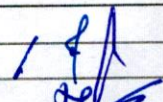
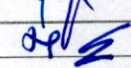
5. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di **PIHAK PERTAMA**, jika dalam proses pelaksanaan Pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan dan Hukum, konflik kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK PERTAMA**, agar melaporkan melalui *Whistle Blowing System* dengan media antara lain telepon, SMS, Whatsapp ke 08119861901, atau email ke wbpln@pln.co.id
6. **PIHAK KEDUA** yang menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini terbukti melakukan larangan-larangan dimaksud pada pasal ini maka dapat dikenakan sanksi-sanksi dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut;
 - a. Pemutusan Perjanjian
 - b. Apabila dilakukan Pemutusan Perjanjian, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke rekening **PIHAK PERTAMA** (apabila ada); dan
 - c. Pengenaan daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 20 KEAMANAN DAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mentaati peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan lokasi kegiatan, keselamatan peserta, kebersihan lingkungan, alat-alat dan material untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pelayanan kesehatan. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul di tempat pekerjaan sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana untuk menjaga dan menjamin keselamatan serta keamanan pekerja, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.
4. Jika para petugas/karyawan **PIHAK KEDUA** mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan Pelayanan Kesehatan ini, maka hal itu merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melapor ke instansi setempat yang terkait / berwenang, dengan menyampaikan tembusannya ke **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian akibat kecelakaan kerja yang dialami **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau sertifikasi kompetensi maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali, yang apabila teguran tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga sesuai dengan maksud ketentuan ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi pemutusan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 21 STANDAR MUTU DAN KUALITAS

Barang-barang dan layanan yang harus disediakan dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam konteks pemberian pelayanan kesehatan adalah dalam keadaan baik, siap pakai dan memenuhi standar kelayakan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 22

PENGHENTIAN (*SUSPENSION*) DAN PEMUTUSAN (*TERMINATION*) KERJASAMA

1. Perjanjian/Kontrak dinyatakan berakhir apabila, mana yang terjadi lebih dahulu
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir
 - b. Disepakati **PARA PIHAK** secara tertulis
 - c. Pengakhiran secara sepihak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian
2. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, korupsi, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan/pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, **PARA PIHAK** wajib membatalkan proses pengadaan/memutuskan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.
3. Penghentian perjanjian dapat dilakukan dalam hal terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau terjadi *Force Majeure*/keadaan kahar
4. Dalam hal akan terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud angka 1, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Apabila salah satu Pihak memutuskan Perjanjian sebelum waktu Perjanjian berakhir, maka Pihak yang mengajukan permintaan pemutusan akan mengajukan secara tertulis dan **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan dan pengadaan obat.

PASAL 23

PENUTUP

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum penuh sampai Pekerjaan dan Pembayaran telah diselesaikan.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Makassar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**


dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

**PT. PLN (PERSERO)
PELAYANAN HUMAN CAPITAL REGIONAL
SULAWESI, MALUKU, PAPUA DAN NUSA
TENGGARA**


MUHAMMAD AKBAR
VICE PRESIDENT